

EMERGENCY OPERATIONS CENTER — PERIODE JULI 2026

# LAPORAN INFOGRAFIS EOC KEMENKES RI: EKSEKUTIF KRISIS KESEHATAN KEBENCANAAN

Analisis Situasi Kebencanaan, Dampak Korban, dan Mobilisasi Kesiapsiagaan Darurat

Periode Pemantauan  
1–31 Juli 2026

Cakupan  
34 Provinsi

Pembaruan Terakhir  
31 Juli 2026, 23:59 WIB

Diterbitkan oleh  
Pusat Krisis Kesehatan  
Kemenkes RI

## ENAM INDIKATOR UTAMA KRISIS KESEHATAN NASIONAL

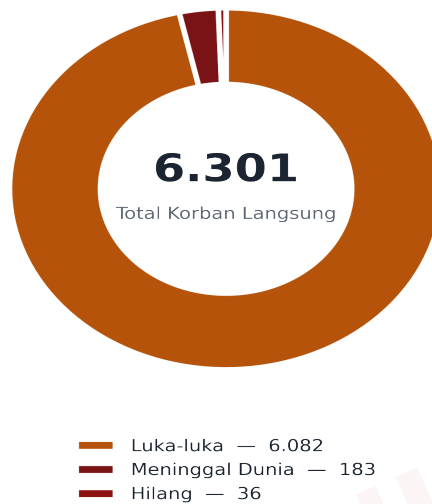


## RINGKASAN EKSEKUTIF ANALISIS SITUASI

Sepanjang periode Juli 2026, Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mencatat eskalasi signifikan beban krisis kesehatan akibat kebencanaan, dengan **484 kejadian** yang berdampak langsung pada **303.380 jiwa** penduduk di seluruh wilayah cakupan pemantauan. Tingginya angka korban meninggal dunia (183 jiwa), korban luka (6.082 jiwa), serta 36 jiwa yang masih dinyatakan hilang menegaskan bahwa tekanan terhadap sistem kesehatan darurat berada pada level yang memerlukan kewaspadaan penuh. Konsentrasi dampak yang tidak merata antarwilayah — dengan Jawa Barat dan Banten menyumbang porsi korban dan pengungsi terbesar secara nasional — menuntut prioritas alokasi sumber daya medis dan logistik kesehatan yang terarah, cepat, dan terukur sesuai prinsip manajemen krisis berbasis risiko.

Kondisi 6.996 jiwa pengungsi yang saat ini berada di posko pengungsian menghadirkan ancaman kesehatan masyarakat sekunder yang tidak kalah serius dibandingkan dampak primer bencana itu sendiri. Kepadatan hunian sementara, keterbatasan sanitasi, dan minimnya akses air bersih pada masa tanggap darurat menjadi faktor pendorong utama peningkatan risiko penyakit menular berbasis lingkungan, khususnya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), Diare, dan penyakit Kulit (skabies dan dermatitis). Ketiga penyakit ini secara historis selalu menjadi penyumbang morbiditas tertinggi di posko pengungsian pada 2–3 minggu pertama pascabencana. Atas dasar ini, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI menetapkan Jawa Barat dan Banten sebagai wilayah prioritas utama intervensi kesehatan darurat, dengan instruksi tegas kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan Provinsi dan Tim EMT untuk mempercepat surveilans penyakit menular, distribusi logistik obat esensial, serta penguatan pos kesehatan lapangan tanpa penundaan.

**Status Komando:** Seluruh Dinas Kesehatan Provinsi terdampak diinstruksikan mengaktifkan status Tanggap Darurat Kesehatan dan melaporkan perkembangan situasi ke EOC Kemenkes RI secara berkala setiap 24 jam.

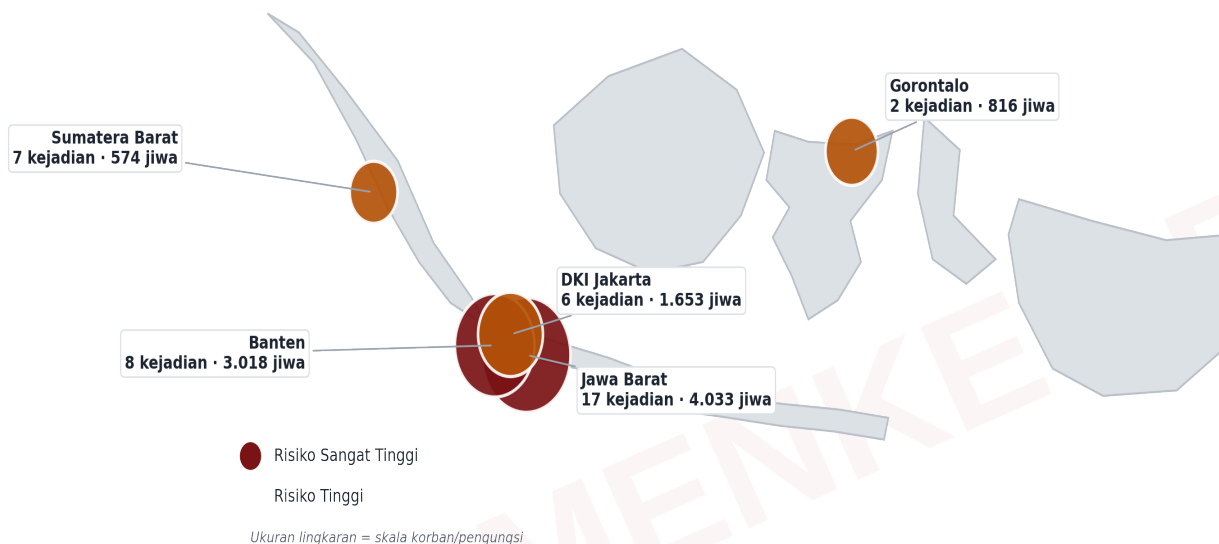


Gambar 1. Komposisi Korban Langsung Bencana — Meninggal, Luka-luka, dan Hilang (Juli 2026)

## PEMETAAN SPASIAL REGIONAL & DISTRIBUSI KEBENCANAAN

Analisis distribusi spasial menunjukkan bahwa dampak krisis kesehatan bulan Juli 2026 terkonsentrasi pada lima provinsi prioritas yang secara kumulatif menyumbang **40 kejadian bencana** dan **10.094 jiwa** korban serta pengungsi. Pola sebaran ini mengonfirmasi karakter krisis yang bersifat klaster regional, sehingga strategi respons wajib disusun secara terdiferensiasi per wilayah, bukan pendekatan seragam nasional.

Peta Ilustratif Sebaran Wilayah Terparah — Juli 2026



Gambar 2. Peta Ilustratif Sebaran Lima Provinsi Terparah — ukuran penanda merepresentasikan skala korban/pengungsi

### 1. Jawa Barat

17 Kejadian · 4.033 Korban/Pengungsi

Wilayah dengan beban tertinggi secara nasional. Frekuensi kejadian yang tinggi dikombinasikan dengan volume korban terbesar menjadikan Jawa Barat sebagai episentrum utama operasi tanggap darurat kesehatan bulan ini.

### 2. Banten

8 Kejadian · 3.018 Korban/Pengungsi

Rasio korban per kejadian yang sangat tinggi mengindikasikan intensitas dampak per lokasi bencana yang berat, menuntut penguatan kapasitas faskes rujukan dan pos kesehatan lapangan secara segera.

### 3. DKI Jakarta

6 Kejadian · 1.653 Korban/Pengungsi

Kepadatan penduduk perkotaan memperbesar potensi penyebaran penyakit menular di titik pengungsian sehingga memerlukan pengawasan epidemiologis yang lebih ketat meski jumlah kejadian relatif moderat.

### 4. Gorontalo

2 Kejadian · 816 Korban/Pengungsi

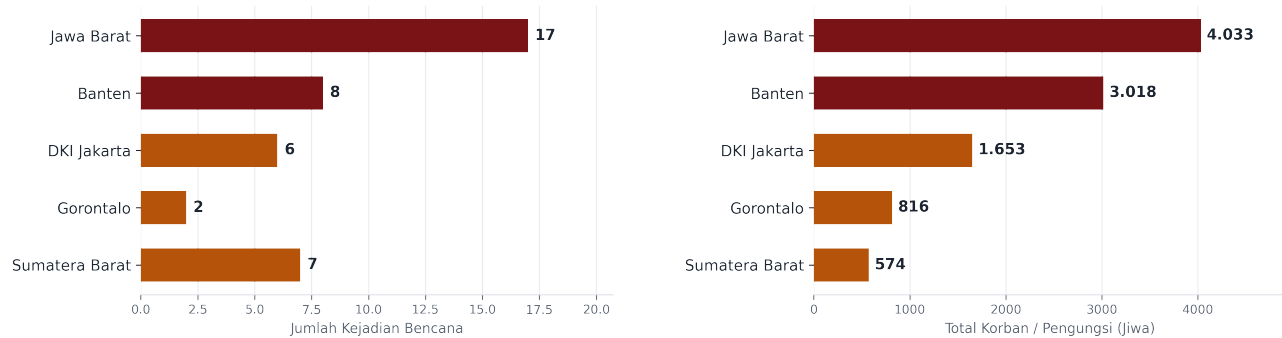
Meski jumlah kejadian paling sedikit, rasio dampak per kejadian tertinggi secara nasional (408 korban/kejadian) menandakan skala bencana tunggal yang besar dan memerlukan mobilisasi logistik lintas wilayah.

### 5. Sumatera Barat

7 Kejadian · 574 Korban/Pengungsi

Karakter kejadian tersebar pada frekuensi cukup tinggi namun dampak per kejadian relatif terkendali, sehingga fokus intervensi diarahkan pada pemantauan dini wilayah rawan berulang.

GRAFIK DISTRIBUSI DAMPAK PER PROVINSI



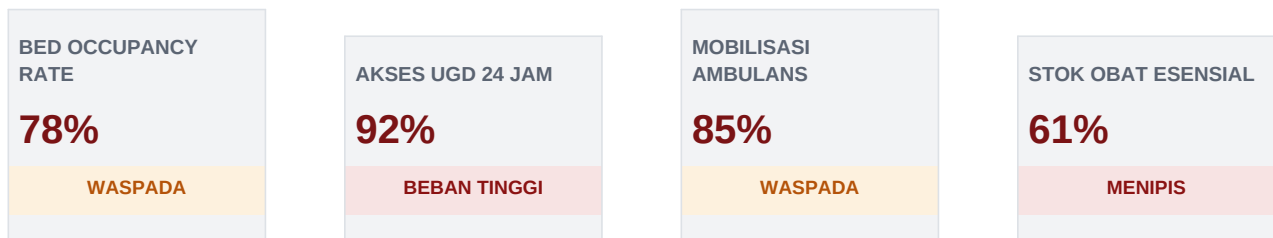
Gambar 3. Jumlah Kejadian dan Total Korban/Pengungsi pada Lima Provinsi Terparah (Juli 2026)

TABEL DISTRIBUSI DAMPAK REGIONAL

| PERINGKAT | PROVINSI       | KEJADIAN | PENGUNGSI/KORBAN | TINGKAT RISIKO |
|-----------|----------------|----------|------------------|----------------|
| 1         | Jawa Barat     | 17       | 4.033            | SANGAT TINGGI  |
| 2         | Banten         | 8        | 3.018            | SANGAT TINGGI  |
| 3         | DKI Jakarta    | 6        | 1.653            | TINGGI         |
| 4         | Gorontalo      | 2        | 816              | TINGGI         |
| 5         | Sumatera Barat | 7        | 574              | TINGGI         |

ANALISIS KAPASITAS FASILITAS KESEHATAN (FASKES)

Penilaian kesiapan faskes rujukan di lima wilayah prioritas menunjukkan tekanan kapasitas yang perlu diantisipasi melalui realokasi sumber daya lintas provinsi, khususnya pada klaster Jawa Barat–Banten yang menanggung beban kasus tertinggi.



**Catatan Komando:** Stok obat esensial di bawah ambang 65% pada klaster Jawa Barat–Banten mewajibkan aktivasi jalur distribusi logistik prioritas dari gudang farmasi regional dalam 1×24 jam.

## REKOMENDASI TAKTIS TIM MEDIS (EMT) & RENCANA KONTINJENSI

Berdasarkan hasil analisis situasi dan pemetaan risiko regional, Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI menginstruksikan pelaksanaan protokol mobilisasi Emergency Medical Team (EMT) Tipe 1 dan Tipe 2 secara berjenjang ke seluruh titik pengungsian pada wilayah prioritas.

1

### Aktivasi & Penugasan EMT Tipe 1 (0–24 Jam)

Mengarahkan EMT Tipe 1 (rawat jalan/mobile clinic) ke posko pengungsian terparah di klaster Jawa Barat dan Banten dalam waktu maksimal 24 jam sejak status siaga darurat ditetapkan, dengan fokus penanganan awal ISPA, Diare, dan penyakit Kulit.

2

### Penguatan EMT Tipe 2 & Rujukan (24–72 Jam)

Menempatkan EMT Tipe 2 (rawat inap darurat) pada faskes rujukan terdekat dari titik pengungsian di DKI Jakarta, Gorontalo, dan Sumatera Barat untuk menopang kapasitas BOR yang berada pada level waspada, disertai jalur evakuasi medis yang jelas.

3

### Surveilans Berkelanjutan & Rotasi Tenaga Kesehatan (72 Jam+)

Menjalankan surveilans penyakit menular harian di seluruh posko, disertai sistem rotasi tenaga kesehatan setiap 7 hari guna menjaga kualitas layanan dan mencegah kelelahan personel selama masa tanggap darurat berlangsung.

## STANDAR KESIAPSIAGAAN SANITASI & PENGUNGSIAN

15 L

### AIR BERSIH PER JIWA/HARI

Standar minimal ketersediaan air bersih di posko pengungsian sesuai pedoman kesehatan lingkungan tanggap darurat.

1 : 20

### RASIO MCK PER PENGUNGS

Satu unit MCK (jamban pengungsian) wajib melayani maksimal 20 jiwa untuk mencegah penularan penyakit berbasis sanitasi.

3x

### DISTRIBUSI DAPUR UMUM/HARI

Penyediaan makanan siap saji secara higienis minimal tiga kali sehari dengan standar gizi darurat bencana.

1 : 500

### RASIO RUANG ISOLASI KRISIS

Area isolasi kesehatan disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus penyakit menular per 500 jiwa pengungsi.

## PUSAT PELAYANAN INFORMASI DARURAT

HOTLINE EOC KEMENKES RI

0812-1212-3119

CALL CENTER DARURAT MEDIS

119 (PSC 119)

COMMAND CENTER 24 JAM

(021) 500-567

Dokumen ini merupakan laporan resmi Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan operasional lintas sektor dalam penanganan krisis kesehatan kebencanaan.

DISAHKAN SECARA  
DIGITAL  
EOC KEMENKES RI  
31-07-2026

dr. [Nama Kepala Pusat]

Kepala Pusat Krisis Kesehatan  
Kementerian Kesehatan RI